psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre	**:** Gustavo Alonso Guzmán Carrasco
R.U.T.	**:** 27. 882. 659 - 7
Fecha de Nacimiento / edad	**:** 31 de julio 2022
Nivel escolar	**:** Sin escolarización
Establecimiento escolar	**:** Sin escolarización
Fecha evaluación	**:** Marzo, 2026

II.- Motivo de consulta

Familia busca continuar con terapia fonoaudiológica debido a dificultades lingüística-comunicativas, cabe señalar que Gustavo asistió al centro terapia del comportamiento durante el mes de enero y febrero, donde incrementaron sus habilidades.

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica.
- Entrevista a padres.
- Pauta de observación semiestructurada fonoaudiológica.
- Pauta del juego de Catsby.
- Pauta cotejo del desarrollo del lenguaje (0-12 meses) Chile crece más.
- Encuesta Pediátrica del Sueño (niños de 2 a 18 años), adaptada por Psicoeduka.
- Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria (PORTAGE)
- Evaluación Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil
- Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)
- Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

V. Análisis de resultados

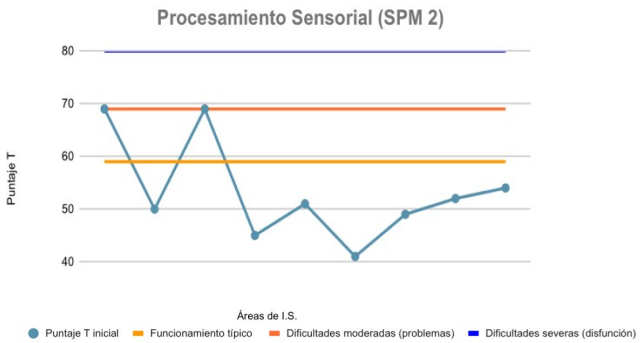
I. Comportamiento observado

Gustavo hace ingreso al aula acompañado de su mamá. En primera instancia molesto, debido a que quería ingresar a la sala de terapia ocupacional, sin embargo, se redirecciona el foco atencional con juguetes de su interés (autos). Se aprecia interés medio por el entorno.

II. Valoración Cuantitativa.

1) Resultado del Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)

Area	Puntaje	Interpretación
Participación Social	69	
Visión	50	Funcionamiento típico
Audición	69	Dificultades moderadas
Tacto	45	Funcionamiento típico
Gusto y Olfato	51	Funcionamiento típico
Conciencia corporal	41	Funcionamiento típico
Equilibrio y movimiento	49	Funcionamiento típico
Planificación e ideas	52	Funcionamiento típico
Puntaje corporal total	**54**	**Funcionamiento típico**



2) Resultados Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI)

TADI	PT	RANGO
Dimensión Cognitiva	23	Retraso
Dimensión Motricidad	31	Riesgo
Dimensión Lenguaje	29	Retraso
Dimensión Socioemocional	23	Retraso
Desarrollo Global	**29**	**Retraso**

3) Resultados Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn

		Puntaje	Categoría
Cuadrantes	Búsqueda/Buscador	32/95	Igual que los demás (0)
	Evitación/Evitativo	38/100	Igual que los demás (0)
	Sensibilidad/Sensitivo	34/95	Igual que los demás (0)
	Registro/Espectador	34/110	Igual que los demás (0)
Procesamiento Sensorial	Auditivo	23/40	Igual que los demás (0)
	Visual	7/30	Menos que los demás (-1)
	Táctil	23/55	Más que los demás (+1)
	Movimiento	18/40	Igual que los demás (0)

	Posición del cuerpo	8/40	Igual que los demás (0)
	Oral	16/50	Igual que los demás (0)
Comportamiento	Conducta	16/45	Igual que los demás (0)
	Socioemocional	24/70	Igual que los demás (0)
	Atencional	12/50	Igual que los demás (0)

III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

Según los resultados obtenidos en el Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI), Gustavo presenta un retraso psicomotor global. Este instrumento evalúa cuatro áreas del desarrollo: motricidad, cognición, lenguaje y socioemocional.
De acuerdo con los puntajes obtenidos, las áreas de cognición, lenguaje y socioemocional se sitúan en la categoría de retraso, mientras que el área de motricidad se ubica en la categoría de riesgo.
Si bien se evidencian desafíos en todas las áreas evaluadas, también se observan fortalezas en habilidades específicas, las cuales permiten estimar una edad de desarrollo aproximada de 2 años. Estas habilidades emergentes constituyen una base relevante para el proceso de intervención.

A continuación, se describen cada una de las áreas del desarrollo, detallando tanto los principales desafíos como las fortalezas observadas en el desempeño de Gustavo.

En cuanto al área de **motricidad**, Gustavo obtiene un puntaje de 31 puntos, ubicándose en la categoría de riesgo, lo que sugiere posibles alteraciones en esta área. No obstante, a partir del análisis cualitativo y la observación clínica, se evidencia un bajo seguimiento de instrucciones, por lo que la no ejecución de algunas tareas evaluadas estaría más asociada a dificultades en la comprensión y respuesta a consignas, que a limitaciones motrices propiamente tales.

Actualmente, Gustavo presenta marcha independiente, con reacciones de equilibrio y enderezamiento presentes. Asimismo, logra saltar con ambos pies, lanzar objetos, construir torres de hasta 7 cubos y trasvasijar el contenido de un vaso a otro sin derramar, lo que da cuenta de un desempeño motor funcional en habilidades básicas.

Sin embargo, en relación con su edad cronológica, se observan desafíos en habilidades que requieren mayor coordinación, imitación y planificación motora, tales como imitar movimientos de manos, pasar páginas de un libro de manera controlada, construir un puente con cubos, caminar en punta de pies, así como habilidades de motricidad fina como doblar una hoja por la mitad presionando el pliegue y cortar una hoja en dos.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

2.- Desarrollo Cognitivo:

Según lo evaluado en protocolo TADI se puede determinar que Gustavo mantiene atención sostenida breve y logra alternar entre estímulo, presenta interés por el entorno y exploración de objetos, además evidencia habilidades de permanencia del objeto (busca objetos escondidos), logra resolución de problemas simples, especialmente en tareas manipulativas (ej: encaje de figuras, uso de objetos concretos) y presenta coordinación visomotora básica funcional, logrando acciones como traspaso de objetos y uso de elementos. Sin embargo, presenta desafíos en función simbólica y uso funcional espontáneo de objetos, ya que requiere modelado o imitación para lograrlo, se observan limitaciones en la emisión de sonidos con intención comunicativa (onomatopeyas), lo que impacta el juego y la representación, mantiene dificultades en habilidades cognitivas de mayor complejidad como: clasificación y categorización, Conceptos básicos (ej: "uno"), discriminación visual más compleja, Memoria auditiva inmediata (repetición de dígitos), reconocimiento de atributos (color, tamaño), dificultad en tareas que requieren mayor abstracción, lenguaje y flexibilidad cognitiva y resolución de tareas más complejas (como rompecabezas) requiere apoyo.

Según lo observado en contexto terapéutico, se aprecia un desarrollo cognitivo en rango descendido, con fortalezas en exploración, atención básica y resolución de problemas concretos, logrando sostener una atención funcional en tareas breves. No obstante, su desempeño disminuye ante mayores demandas cognitivas, evidenciando desafíos en funciones complejas como simbolización, categorización, lenguaje y flexibilidad cognitiva. Asimismo, presenta baja tolerancia a la frustración y tendencia a la rigidez, requiriendo apoyo del adulto para sostener la actividad y enfrentar nuevas tareas.

3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

III.1 Etapa lingüística:

En base a los hallazgos visualizados en la pauta de cotejo del desarrollo del lenguaje del programa Chile crece, se identifica que Gustavo se encuentra iniciando la etapa lingüística (12 meses). Debido a que presenta primeras palabras con sentido, cabe destacar que debido a la sospecha diagnóstica de condición del espectro autista aquellos contenidos en la dimensión de uso (pragmática) presentan un desarrollo inferior en comparación a las dimensiones de forma y contenido.

III.1.1 Exploración sistema estomatognático:

Se aprecia simetría facial, músculos orbicular de los labios, mentoniano y buccinador con tono normal, en cuanto a la cavidad oral esta no se logra inspeccionar debido a evitación de Gustavo por mostrar lengua y dientes, por consiguiente, tampoco es posible evaluar movimientos orales no verbales (praxias).

III.1.2 Dimensión de forma:

Gustavo presenta un repertorio fonético limitado, el cual se compone de las vocales /a/, /o/, /u/ y de las consonantes /m/, /n/ y /p/. Emite distintas vocalizaciones asociadas a estados de ánimo (enojo y alegría). No voltea de manera espontánea al nombre, se debe insistir en la solicitud, la cual mejora con apoyo de la madre. No identifica auditivamente animales mediante onomatopeyas.

III.1.3 Dimensión de contenido:

Gustavo produce onomatopeyas de animales (león, perro, vaca, elefante), denomina y reconoce algunas frutas y verduras (uva, plátano, brócoli y zanahoria), en la categoría semántica de artículos del hogar identifica la cuchara y les da uso funcional en dinámica de juego a la cuchara, olla, tenedor y vaso. Produce a repetición mamá y papá con apoyo de cambio de resonancia para llamar su atención (conos de papel higiénico). Comprende la orden de "toma" y "dame" de manera consistente. Emite el "no" cuando no se brinda lo deseado. Sigue las dinámicas de guardar y ordenar.

III.1.4 Dimensión de uso:

Posee contacto visual inconsistente, instrumentaliza al adulto para que este busque objetos que no están a su alcance, con relación a atención conjunta sigue el gesto emitido por el interlocutor de manera breve, comparte emoción e interés por descubrimientos nuevos (por ejemplo: sonidos de instrumentos musicales), en cuanto a la habilidad de imitación, no imita actos motores (aplausos), pero sí sonidos vocálicos y el uso de instrumentos musicales (mover sonajeros). No utiliza gestos sociales.

4.- <u>Desarrollo socioemocional</u>.

En base a la pauta del juego de Casby, se logra determinar que Gustavo está desarrollando un juego funcional-convencional, donde se aprecia el uso de objetos no descontextualizados de los ambientes reales en los que son utilizados (por ejemplo: empujar auto de juguetes, dar de comer animales, beber agua de un vaso), pese a esto tiende a perseverar en apilar y ordenar objetos.

Según lo observado mediante protocolo TADI, en el ítem de **dimensión socio emocional** se puede apreciar expresión de agrado y desagrado, evidenciando una base de comunicación emocional, respuestas a la interacción con el adulto (sonrisa, contacto), mostrando vínculo y reconocimiento social básico. Presenta conductas de apego funcional, como disfrutar del contacto físico con adultos significativos. Logra regularse en situaciones básicas, calmándose con apoyo o en tiempos esperados. Participa en juegos interactivos con el adulto, principalmente de tipo sensorial. Muestra autonomía en rutinas (alimentación, seguimiento de hábitos). Puede seguir rutinas con facilidad, lo que indica buena adaptación a estructuras conocidas. Sin embargo, presenta desafíos en la interacción con pares, con bajo interés o escasa participación en juego compartido, posee limitaciones en habilidades de reciprocidad social como: Compartir, Consolar, Expresar satisfacción socialmente. Además, presenta dificultad para reintegrarse al juego tras situaciones de estrés, lo que sugiere desafíos en regulación emocional. Escasa expresión emocional más compleja, incluyendo identificación y reconocimiento de emociones en otros y evidencia baja iniciativa para comunicar preferencias o intereses sociales.

5.- <u>Procesamiento sensorial y conducta</u>

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pautas SPM-2 y Perfil Sensorial 2, respondidas por la madre, Gustavo presenta un procesamiento sensorial general dentro de un funcionamiento típico. No obstante, se evidencian dificultades moderadas en el procesamiento auditivo, configurando un perfil sensorial caracterizado principalmente por hipersensibilidad, lo que puede impactar en su desempeño funcional y en su respuesta frente a estímulos del entorno.

En el procesamiento auditivo, se observan respuestas aumentadas frente a estímulos sonoros, manifestando incomodidad o reacciones intensas ante ruidos del ambiente. Esta hipersensibilidad puede interferir en su capacidad de atención, generar conductas de evitación y dificultar la participación en contextos con alta carga auditiva, como espacios grupales o situaciones cotidianas con múltiples estímulos. No obstante, en contexto terapéutico, en algunas ocasiones Gustavo ha evidenciado incomodidad frente a ruidos externos, cubriéndose los oídos, sin presentar conductas desreguladas o respuestas conductuales intensas.

A nivel clínico, durante el proceso terapéutico se observa además un aumento de la actividad motora, manifestándose como inquietud, necesidad constante de movimiento y dificultad para mantener un estado de calma. Este patrón podría interpretarse como una estrategia de autorregulación frente a la sobrecarga sensorial, especialmente en contextos auditivamente demandantes. Asimismo, se observa alta tolerancia al dolor y dificultades para percibir cambios de temperatura, lo que podría indicar una hiporrespuesta a nivel propioceptivo, asociada a una baja conciencia corporal.

Por otra parte, se evidencia una afectación en la participación social, observándose dificultades para integrarse en actividades compartidas, responder de manera adecuada a estímulos sociales y sostener interacciones con otros. Estas dificultades podrían estar relacionadas tanto con una baja intención de interacción con pares, como con la forma en que Gustavo procesa la información del entorno social, evidenciándose mayor rechazo en contextos con mayor carga sensorial, especialmente auditivo.

6.- <u>Perfil ocupacional</u>

- **Actividades de la vida diaria:** Gustavo, de 3 años de edad, presenta un desarrollo heterogéneo en las actividades de la vida diaria, evidenciándose avances en habilidades básicas junto a dificultades en aquellas que requieren mayor autonomía, coordinación y secuenciación de acciones.

  En el área de **alimentación**, se observa que Gustavo ha adquirido habilidades iniciales como el uso de utensilios (cuchara) y la ingesta autónoma de algunos alimentos, además de beber líquidos desde vaso o taza. Sin embargo, persisten dificultades en habilidades más complejas propias de su rango etario, tales como el manejo adecuado del derrame, el uso coordinado de utensilios como tenedor, y la manipulación de líquidos (servir o controlar cantidad).

  Respecto al **vestuario**, Gustavo logra participar en actividades básicas como quitarse algunas prendas (calcetines, abrigo, zapatos cuando están sueltos) y colaborar parcialmente en el proceso de vestido. No obstante, presenta dificultades en tareas que implican mayor organización motora y secuenciación, como abrochar, desabrochar, identificar correctamente la orientación de la ropa o completar el vestido de manera independiente.

  En el área de **higiene**, se evidencian avances en conductas iniciales como el lavado de manos con apoyo, la imitación en el cepillado dental y el uso del baño con asistencia. Además, logra comunicar en algunas ocasiones la necesidad de ir al baño, lo que constituye un indicador positivo

en la adquisición de control de esfínteres. Sin embargo, requiere supervisión constante para completar rutinas de higiene de forma adecuada y consistente, observándose dependencia en la secuencia y ejecución de estas actividades.

En relación al autocuidado y seguridad, Gustavo presenta conductas básicas de evitación de peligros, lo cual es acorde a su edad. No obstante, estas habilidades aún requieren consolidación, especialmente en contextos menos estructurados.

A nivel general, el perfil observado muestra que Gustavo presenta un desempeño funcional por debajo de lo esperado para su edad cronológica, especialmente en tareas que demandan autonomía, organización, planificación y secuenciación de acciones. Se evidencia una mayor dependencia del adulto para iniciar, mantener y finalizar actividades de la vida diaria.

- **Descanso y sueño:** Según la Encuesta Pediátrica del Sueño, Gustavo presenta un patrón de sueño adecuado, con rutina estable, conciliando el sueño alrededor de las 21:00 horas y una duración aproximada de 12 horas diarias, acorde a su edad. No se reportan despertares frecuentes ni alteraciones respiratorias, evidenciando una adecuada calidad y continuidad del descanso.

  En relación con hábitos, se observa uso de pantallas durante el día, finalizando antes de las 17:00 horas, manteniendo un intervalo adecuado previo al sueño. Si bien se presentan algunas conductas diurnas como distracción e inquietud motora, estas no se asocian directamente a dificultades en el descanso, sino más bien a aspectos de regulación conductual.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de evaluación interdisciplinario, los instrumentos aplicados, los criterios diagnósticos del manual de clasificación DSM-V, es posible señalar que Gustavo posee un trastorno del lenguaje secundario a sospecha de trastorno del espectro autista. Sumado a lo anterior, se aprecia un retraso global en su desarrollo psicomotor, sobre todo en área cognitiva, de lenguaje y socioemocional.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

- Jugar explorando, ir mostrándole distintos fenómenos “mira los bichitos”, “mira el avión que va en el cielo”, etc.
- Jugar a copiar acciones motoras y canciones relativas al esquema corporal (“saco una manito”).
- Habla paralela, el adulto debe ir comentando lo que ocurre, aunque no aparente demostrar interés.
- Continuar explorando intereses particulares (dinosaurios, autos, jugar con pintura etc.)
- Aprovechar experiencias cotidianas que demuestran causa-efecto, por ejemplo: suena el timbre y decir “¡oh! Escuchas, ¿qué sonó ahí?, ¿quién viene?”
- Se deriva a odontopediatra, para que Gustavo comience sus controles dentales.
- Se sugiere comenzar proceso de escolarización en nivel correspondiente a su edad (nivel medio mayor).
- Debido a que Gustavo ya mantiene control con neurólogo, se indica mantener la periodicidad de las consultas, con el fin de conocer los lineamientos a seguir por parte del especialista.

Javiera Carvajal Herrán
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 691375
GRUPO PSICOEDUKA

K. molina.
Karina Molina Morales
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 684122
Reg. EDU: 358933
GRUPO PSICOEDUKA

Valeska Ananías Gómez
Directora Clinica
GRUPO PSICOEDUKA

Katherinne Luna Godoy
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 369796
Reg. EDU: 298810
GRUPO PSICOEDUKA

Rocío Ormazábal Cabello
Psicopedagoga
Coordinadora Sede Viña del Mar
Reg. EDU: 275863
GRUPO PSICOEDUKA

Viña del mar, Abril 2026.